

QCM Chirurgie pédiatrique - VarB 2018

1. *L'atrésie de l'oesophage de type III supposons:
 - A. Les deux segments oesophagiens ne communiquent pas avec la trachée
 - B. Le segment proximal communique avec la trachée et se trouve à moins de 2 cm du segment distale
 - C. Le segment proximal communique avec la trachée et se trouve à plus de 2 cm du segment distale
 - D. Les deux segments oesophagiens communiquent entre eux
 - E. Aucune réponse n'est correcte

2. *Dans l'omphalocèle le diagnostic prénatal positif se fait par :
 - A. Échographie abdominale après la 13-14ème semaine de grossesse
 - B. Radiographie abdominale en orthostatisme
 - C. CT dans le premier mois de grossesse
 - D. Scintigraphie avec tc99
 - E. Toutes ces réponses sont correctes

3. *Dans l'hernie hiatale, le diagnostic de certitude est établi par :
 - A. D'après du caractère du vomissement
 - B. Radiographie thoracique de face
 - C. Radiographie thoracique de profil
 - D. Radiographie abdominale sans préparation en orthostatisme
 - E. Examen radiologique répéter en position Trendelenburg

4. * Dans l'atrésie intestinale de type I se rencontre :
 - A. La continuité de paroi séro-musculaire, avec la lumière bloquée par des septums multiples
 - B. Entre les segments fermés de l'intestin il y a un cordon fibreux, le mésentère est intact ou interrompu en "V"
 - C. Les segments fermés sont complètement séparés, défaut mésentérique en "V"
 - D. Zone atrésiques multiples, complètement séparés, défauts mésentériques en "V" réalise "l'aspect de pagode"
 - E. Aucun des problèmes mentionnés

5. * Les déclarations suivantes sur la paralysie du nerf facial sont vraies, avec une exception que vous devez indiquer :
 - A. La plus fréquente lésion du système nerveux périphérique
 - B. Ce produit par une compression du nerf par l'épaule du fœtus dans diverses positions viciées intra-utérine
 - C. La conséquence la plus grave est la paralysie de la branche orbitale avec immobilisation de la paupière supérieure
 - D. Le traitement vise la protection de la cornée jusqu'au rétablissement de la fonction nerveuse
 - E. Elle est toujours bilatérale

6. *La persistance du canal omphalo-mésentérique signifie :
 - A. Persistance de la portion interne de ductus omphalo-entérique
 - B. Persistance de la portion externe de ductus omphalo-entérique
 - C. Communication perméable entre l'ombilic et l'iléon, par un orifice visible centrale par où s'extériorise un liquide avec contenu intestinale en fonction du calibre du conduit
 - D. Communication perméable entre l'ombilic et la vessie
 - E. Communication imperméable entre l'ombilic et l'iléon

7. *Dans les fentes du voile palatin (palais mou) :
- A. Lames palatine sont unies mais pas le palais mou
 - B. avec la croissance les lames palatine se rapprochent ensemble avec le palais mou
 - C. avec la croissance les lames palatines, s'écartent mais pas le palais mou
 - D. avec la croissance les lames palatine s'écartent ensemble avec le palais mou
 - E. la croissance n'influence en rien les dimension du défaut
8. * Bosse séro-sanguine :
- A. Lésion fréquente du tissu cellulaire sous-cutané, se résorbe spontanément durant la première semaine de vie
 - B. c'est un hématome sous-périostal, se résorbe spontanément durant la première semaine après la naissance
 - C. c'est une lésion commune du tissu cellulaire sous-cutané, ne se résorbe pas spontanément après la naissance, nécessitant un traitement chirurgical
 - D. nécessite la réalisation d'une incision d'évacuation
 - E. nécessite un traitement antibiotique
9. *Le premier geste de diagnostic dans l'atrésie de l'oesophage est :
- A. La réalisation d'une radiographie avec substance de contraste
 - B. la tentative d'introduction d'une sonde dans l'estomac, s'arrête à 10-12 cm de l'arcade dentaire
 - C. réalisation d'un CT (scanner)
 - D. effectuer une bronchoscopie pour mettre en évidence la fistule oeso-trachéale
 - E. aucune réponse n'est correcte
10. *Fistules et kystes cervicaux latéraux :
- A. Apparaissent à la suite d'imperfections lors du développement un bourgeon frontal
 - B. apparaissent à la suite d'imperfections lors du développement (a mugurilior maxilari) bourgeon maxillaires
 - C. apparaissent à la suite d'imperfections lors du développement des arcs et sillons brachiaux
 - D. toutes les variantes sont correctes
 - E. aucune réponses n'est pas correcte
11. La fistule oeso-trachéale en "H" :
- A. Est la malformation plus fréquente de l'œsophage
 - B. l'œsophage sans être interrompu communique avec la trachée par une fistule latérale
 - C. Est cliniquement reconnu après un symptôme capital, la toux répété durant l'allaitement
 - D. le traitement est exclusivement chirurgical et mène à l'élimination de la fistule
 - E. se ferme spontanément aux premiers mois de la vie
12. La sténose hypertrophique du pylore se manifeste cliniquement par :
- A. Vomissement blanc symptômes dominant la maladie
 - B. vomissement bilieux
 - C. péristaltisme gastrique - ondes contractiles visibles dans l'épigastre
 - D. hyper salivation abondante
 - E. palpation de l'olive pylorique dans l'hypochondre droit sous-hépatique pendant l'alimentation de l'enfant ou en décubitus latéral gauche
13. Lymphadénite mésentérique :
- A. Cause la plus fréquente de douleurs abdominales chez les nourrissons
 - B. ayant comme substrat anatomo-pathologique l'inflammation des ganglions mésentériques situés dans l'angle iléo-caecal
 - C. ayant comme substrat anatomo-pathologique l'inflammation des ganglions rétropéritonéaux
 - D. l'étiologie est microbienne et virale
 - E. les ganglions impliqués sont hypertrophiés et s'accompagnent d'une réaction liquidienne abondante dans la cavité péritonéale

14. Le mégacôlon congénital se manifeste par :
- A. Absence de transit intestinal
 - B. distension abdominale progressive
 - C. boulimie
 - D. vomissement alimentaire au début puis bilieux et ultérieurement fécaloïde
 - E. épisode de diarrhée paradoxale avec émission de selles molles malodorantes
15. Les causes favorisant la production de l'invagination intestinale chez les enfants sont :
- A. Polype intestinal
 - B. diverticule de Meckel
 - C. tumeur intestinale bénigne et maligne
 - D. hernie ombilicale
 - E. parasitose (boule de vers rond)
16. Dysplasie luxant coxo-fémoral :
- A. Se produit à l'âge de 1 ans
 - B. et plus fréquente chez les garçons
 - C. survient le plus souvent dans la race noire
 - D. localisation unilatérale gauche est plus fréquente
 - E. transmission héréditaire dans 10 % des cas
17. Le tableau clinique dans la péritonite primitive comprend :
- A. Début brusque avec douleur abdominale violente péri-ombilicale ou sous-ombilical
 - B. absence de la fièvre
 - C. régurgitation
 - D. pendant la période d'état il n'existe pas de défense musculaire évidente
 - E. fréquemment s'associe l'herpès labial
18. Appendicite aiguë :
- A. Viens le plus fréquemment chez le nouveau-né
 - B. est la plus fréquente cause de douleur abdominale chez l'enfant
 - C. et plus rare chez le nourrisson et le petit enfant mais à cet âge un diagnostic tardive et une péritonite peuvent mener au décès
 - D. le tableau clinique et l'évolution sont différents chez le petit enfant face à l'adulte à cause des moyens locaux et généraux de défense plus réduits
 - E. et plus fréquentes dans le sexe masculin
19. Les signes cliniques de l'atrésie intestinale sont représentés par:
- A. Vomissement bilieux
 - B. distension abdominale
 - C. absence de transit méconial
 - D. hypersalivation
 - E. diarrhée
20. Dans le volvulus intestinal :
- A. Le début brusque en plein état de santé avec pleurs vomissements bilieux et distension abdominale épigastrique rapide et progressive
 - B. très vite la quantité des vomissements change et devient fécaloïde et ayant même un contenu sanguin
 - C. l'émission de sel manque ou quelquefois il existe une émission de selles méléniques
 - D. l'état général se détériore rapidement
 - E. apparaît l'hydrops vésiculaire

21. Pneumothorax :
- A. Présente l'accumulation d'air libre dans la cavité pleurale avec compression du poumon vers le hile
 - B. représente l'accumulation de sang libre dans la cavité pleurale avec compression du poumon vers le hile
 - C. le plus souvent lors des plaies pénétrante
 - D. radiologique - hyper transparence d'un hémithorax
 - E. quand il est rencontré en même temps que l'hémithorax - hémopneumothorax
22. Dans le laparoschisis :
- A. Déficit pariétal para-ombilical droit de 2-3 cm par lequel s'extériorise l'intestin grêle et le côlon
 - B. le cordon ombilical est absent
 - C. l'intestin est mal enroulé dû à l'absence du processus de coalescence et les anses éviscérées sont grises, grosses, adhérentes, oedématisées à cause du contact avec le liquide amniotique et le retour veineux et lymphatique difficile au niveau de l'orifice
 - D. l'intestin est plus court ($\frac{1}{3}$ de la taille normale)
 - E. Rarement associés la prématurité
23. Les anomalies urétérales de forme et calibre comprennent :
- A. Urètre rétro-cave
 - B. diverticule urétéral
 - C. urétérocèle
 - D. sténoses congénitales urétérales
 - E. méga uretère congénital
24. Volet costal :
- A. Se forme à partir de fractures costales multiples avec apparition d'un segment pariétal indépendant d'un point de vue morphologique et fonctionnel
 - B. est caractérisé par l'apparition de mouvements respiratoires paradoxaux
 - C. ne cause pas d'insuffisance respiratoire
 - D. il peut être nécessaire de réaliser une IOT avec support respiratoire
 - E. le traitement est toujours chirurgical
25. Dans l'invagination intestinale, la palpation de l'abdomen peut mettre en évidence :
- A. la fosse iliaque droite est vide (signe Dance) dû à l'invagination du caecum
 - B. hydrops vésiculaire
 - C. la tumeur d'invagination peut se palper le plus souvent au niveau sous-hépatique
 - D. loge rénale droite sensible à la palpation
 - E. l'olive pylorique hypertrophiée
26. Néphroblastome se manifeste clinique par :
- A. Tumeur avec contact lombaire de dimensions variables, lisse ou bosselée, ferme, légèrement mobile
 - B. douleur vague, quelques fois irradiante vers la cuisse, accompagnée de claudication
 - C. hématurie macroscopique
 - D. hypertension artérielle par compression rénale
 - E. diarrhée profuse
27. Hernie inguinale du sexe féminin :
- A. Les dimensions sont plus petites et la strangulation est très rare
 - B. rarement visible chez les nourrissons
 - C. ne se strangule jamais
 - D. une réduction difficile signifie l'engagement d'un ovaire
 - E. il se guérit spontanément à la puberté

28. Myéloméningocèle avec l'aire médullaire ouverte :
- A. présente d'une zone centrale rouge, saignante, avec un orifice central par lequel s'écoule du LCR
 - B. est une formation tumorale lombo-sacrée recouverte de la peau
 - C. présente en périphérie une zone de transition avec la peau fine
 - D. lame vertébrale absente et postérieure le canal médullaire est ouvert
 - E. guérir spontanément dans le premier mois après la naissance
29. Les énoncés suivants concernant le traumatisme obstétrical vertébro médullaire sont faux :
- A. Plus souvent C1-C2 lors des naissances crâniennes ou la rotation de la tête est forcée, ou C7-D1, conséquence de la traction inverse lors des naissances pelviennes
 - B. la section médullaire est mortelle
 - C. peut se manifester par un choc spinal avec hypotonie hyporéflexie et détresse respiratoire
 - D. les fractures vertébrales sont faciles à mettre en évidence sur une radiographie
 - E. après l'âge de 4 ans sont plus fréquentes chez le sexe masculin
30. La sténose hypertrophique du pylore se manifeste radiologiquement (examen du baryum) par :
- A. Canal pylorique large et allongé
 - B. canal pylorique filiforme, allongé
 - C. estomac à faible volume
 - D. estomac dilaté
 - E. la présence de baryum dans l'estomac plus de 4 heures après l'ingestion
31. Dans la maladie Lobstein :
- A. Les malades sont de petite taille
 - B. les malades ont une taille normale
 - C. les dents sont implantées de façon vicieuse
 - D. la denture n'est pas affectée
 - E. les fractures multiples se produisent après des traumatismes mineurs
32. Préopératoire dans la hernie diaphragmatique il est nécessaire :
- A. le positionnement en décubitus latéral du côté sain
 - B. positionnement en décubitus latéral sur la partie affectée
 - C. sonde naso-gastrique
 - D. administration de lait maternel
 - E. intervention chirurgicale par voie abdominale
33. Lesquels des énoncés suivants au sujet de la hernie inguinale du nouveau-née et du nourrisson sont vrais :
- A. Peut apparaître avec les premiers pleurs, surtout chez les prématurés
 - B. Par augmentation de la pression abdominale le canal s'élargit et permet l'engagement et la progression d'une anse abdominale
 - C. dans la majorité des cas se réduit spontanément sauf dans les moments d'efforts et si elle est volumineuse se maintient aussi pendant le repos descend dans le scrotum
 - D. si elle apparaît après l'effort - hernie incoercible
 - E. à l'occasion de la réduction on apprécie la taille de l'orifice inguinal externe par insertion du petit doigt à partir du scrotum
34. Iléus méconial :
- A. représente une obstruction jéuno-iléales du nouveau-né
 - B. toujours associé à une fibrose kystique du pancréas
 - C. n'est pas associé à la mucoviscidose
 - D. est fréquemment associé à l'atrésie des voies biliaires
 - E. se produit dans l'hypertension portale avec hypersplénisme

35. traitement des défauts labiaux et palatins :
- A. formes simples de fente labiale s'opèrent à 2-3 mois après la naissance
 - B. formes simples de fente labiale s'opèrent à 6-8 mois après la naissance
 - C. les cas de fente labiale complète s'opèrent à l'âge de 6 mois
 - D. Défauts de palais sont corrigées à l'âge de 18-24 mois
 - E. défauts de palais sont corrigés à 6 mois et de la lèvre 18-24 mois
36. La strangulation de la hernie inguinale se manifeste par :
- A. douleur
 - B. vomissements
 - C. accélération du transit intestinal
 - D. tumeur inguinal sensible à la palpation
 - E. aucun signe ci-dessus
37. Fractures obstétricales crâniennes :
- A. sont fréquentes grâce aux sutures cartilagineuse qui permettent la déformation du crâne
 - B. sont le plus souvent des lésions linéaires
 - C. sont le plus souvent des lésions avec pénétrations
 - D. quelques fois accompagnées d'un céphalématome
 - E. fractures avec pénétration plus de 5-6 mm nécessite une correction chirurgicale afin d'éviter tous troubles neurologiques
38. Hypospadias :
- A. consiste à ouvrir de l'urètre sur la face dorsal du pénis
 - B. consiste à ouvrir l'urètre sur la face ventrale du pénis
 - C. est associé avec une coudage peno-glandulaire
 - D. est associé avec une coudage péno-scrotale
 - E. est associé à l'incontinence urinaire
39. Hydrocèle :
- A. est une formation kystique contenant de liquide clair, situé dans un reste de canal péritonéovaginal
 - B. apparaît par une dilatation des veines spermatiques
 - C. c'est causé par l'accumulation de sang dans la vaginale testiculaire
 - D. peut disparaître spontanément jusqu'à l'âge de 1 an
 - E. est non douloureuse à la palpation
40. Dans la sténose anale :
- A. orifice anal est normalement situé
 - B. orifice anal est ectopique
 - C. canal anal obturé incomplètement par un diaphragme muqueux
 - D. canal obturé complètement par un diaphragme muqueux
 - E. selle avec aspect de crayon
41. traumatismes obstétricaux de la peau et du tissu sous-cutané :
- A. sont les plus fréquents et les moins graves traumatismes obstétricaux
 - B. sont rares et les moins graves traumatismes obstétricaux
 - C. apparaissent surtout au niveau de certaines proéminences (oreilles, nez, yeux, extrémités, organes génitaux) surtout après les manoeuvres obstétricales
 - D. représentent souvent des portes d'entrée pour les infections (ostéomyélite, gangrène cutanée extensive, furonculose)
 - E. ils guérissent toujours avec les séquelles

42. Les lésions malformatives résultant d'une résorption incomplète ou de la persistance du canal omphalo-entérique comprend :
- A. fistule ombilicale aveugle
 - B. diverticule de merckel
 - C. persistance du canal peritoneo-vaginal
 - D. le diverticulum oesophagien
 - E. fistule ombilicale de l'ouraque
43. Les malformations possibles associées aux malformations duodénales sont :
- A. mongolisme dans 30% des cas
 - B. malformations cardiaques
 - C. malformations veineuse
 - D. malformations de l'intestin grêle
 - E. prématurité
44. saignement (hémorragie) par diverticule iléal de meckel :
- A. Se produit par ulcération de la muqueuse iléale adjacente aux îlots de muqueuse gastrique sécrétante
 - B. les saignements ne sont pas douloureux
 - C. dans les petits saignements répétés se modifie la couleur des selles sans en modifier la consistance
 - D. dans les saignements abondants et répétés se modifie autant la couleur que la consistance des selles et survient des signes de choc hypovolémique
 - E. est accompagné par coliques abdominales
45. Fistule ombilicale aveugle :
- A. Représente la persistance de la portion externe du conduit omphalo-entérique
 - B. Est tapissé de muqueuse digestive sécrétoire produisant une sécrétion séreuse
 - C. l'exploration se fait avec une sonde boutonnée ou par radiographie avec substance de contraste de profil
 - D. le traitement est chirurgical consiste en l'excision de la fistule sans ouverture du péritoine exception faite des cas dans lesquels la fistule se continue par un cordon fibreux vers l'iléon et le méésentère
 - E. ne nécessite pas de traitement chirurgical
46. Hernie hiatale :
- A. est produit par foramen Morgani
 - B. est produit par foramen Bochdalek
 - C. est produit par hiatus oesophagiens
 - D. en association avec SHP - syndrome Rovinalta
 - E. est produit par foramen ovale
47. Les déclarations suivantes sur l'hygrome sont fausses :
- A. est continuité de multiples formations kystiques de différentes dimensions, disposées de façon anarchique et séparées entre elles par des septums endothéliaux
 - B. envahit les muscles et adhère aux vaisseaux et aux nerfs
 - C. n'envahit pas le muscle et n'adhère pas aux vaisseaux et aux nerfs
 - D. localisé le plus souvent dans la zone latéro-cervicale ou axillaire
 - E. localisé le plus souvent dans la zone palmaire ou plantaire

48. Cliniquement dans la hernie diaphragmatique congénitale nous rencontrons :
- A. la respiration polypnéique
 - B. a la percussion, sonorité pulmonaire physiologique
 - C. a la percussion sonorité pulmonaire remplacée par la matité
 - D. a l'auscultation: silence respiratoire, les bruits du péristaltisme sont percevable dans le thorax
 - E. les bruits cardiaques s'entendent du côté droit
49. Dans l'atrésie de l'oesophage on rencontre les symptômes suivants :
- A. impossibilité de déglutition
 - B. troubles respiratoires
 - C. hypersalivation et stagnation bucco-pharyngée des sécrétions
 - D. la crise de toux et la cyanose
 - E. polydipsie
50. Traitement chirurgical des fistules et des kystes cervicaux latéraux branchiogéniques :
- A. Suppose l'extirpation de tout le trajet fistuleux
 - B. se fait en pleine poussée inflammatoire
 - C. pour des raisons d'esthétique on pratique incisions transversales étagées
 - D. se fait après résolution de la poussée inflammatoire
 - E. pour des raisons d'esthétique on pratique incisions vertical étagées

QCM Chirurgie pédiatrique - 2020

1. *La forme anatomo-pathologique d'hydrocèle qui peut guérir spontanément est :
 - A. Hydrocèle vaginale
 - B. kyste du cordon
 - C. hydrocèle communicant
 - D. toutes les formes énumérées
 - E. kyste du canal de Nuck

2. *La cause la plus fréquente d'hydronéphrose congénitale est:
 - A. un rein en fer de cheval
 - B. vaisseaux polaires inférieurs
 - C. haut insertion de l'uretère
 - D. sténose de jonction pyélo-urétérale
 - E. rein ectopique

3. *Dans la hernie hiatale l'angle de Hiss (forme par le fornix gastrique et l'oesophage) :
 - A. est exactement à 90 degré
 - B. ne change pas de la normale
 - C. est inférieure à 90 degré
 - D. c'est obtus, essuye ou disparaît
 - E. aucune réponse n'est correcte

4. *Dans le mégacôlon congénital :
 - A. jéjunale
 - B. anale
 - C. recto-sigmoïde
 - D. iléale
 - E. caecale

5. *Dans l'atrésie duodénale le symptôme dominant est représenté par :
 - A. vomissements méconiaux
 - B. l'abdomen météorise
 - C. vomissements bilieux - apparaît dans 90% des cas dans les premières 24 heures
 - D. vomissements blancs
 - E. selles diarrhéiques

6. *Les invaginations plus fréquentes sont :
 - A. iléo-caeco-colique
 - B. ano-rectale
 - C. duodéno-jéjunale
 - D. jéjuno-iléale
 - E. gastro-duodénale

7. *Dans la lymphadénite mésentérique :
 - A. dans l'épigastre
 - B. dans la fosse iliaque gauche
 - C. dans la fosse iliaque droite
 - D. périombilicale
 - E. dans l'hypogastre

8. *Dans la malrotation intestinale avec volvulus la radiographie avec solution de contraste indique :
- A. l'image en "tire-bouchon"
 - B. la présence de la substance de contraste au-dessus et au-dessous de l'anse volvulée
 - C. l'image en balance
 - D. opacification de toute le cadre colique
 - E. rétention de la substance de contraste dans l'anse volvulée
9. Les hémangiomes :
- A. Sont des tumeurs vasculaire composée de capillaire de néo-formation de type malin
 - B. ils peuvent être localisé dans toutes les parties du corps
 - C. ils sont de différentes tailles
 - D. sont des tumeurs vasculaire composé de capillaire de néo-formations de type Bénin
 - E. le sexe féminin est plus fréquemment affecté
10. Hygromas :
- A. Et une formation tumorale de la peau
 - B. dans les poussées inflammatoires les troubles respiratoires s'aggrave
 - C. est constitué de multiples formation kystique localiser dans la zone cervicale
 - D. son prolongement médiastinale s'accompagne de dyspnée
 - E. disparaissent spontanément à la puberté
11. le tableau clinique de la fracture obstétricale de la clavicule :
- A. La fracture obstétricale de la clavicule survient dans les premiers jours après la naissance
 - B. l'examen clinique peut révéler un callus hypertrophique détectable à la palpation
 - C. le nouveau-né avec une fracture de la clavicule est agitée et cri à la mobilisation du membre du côté de la lésion
 - D. Est dominé par l'impotence fonctionnelle totale du membre du côté affecté
 - E. la fracture obstétricale de la clavicule se produit spontanément où est provoqué intentionnellement pour la libération d'une épaule dystocique à la naissance
12. Les complications des hémangiomes sont :
- A. L'ulcération
 - B. L'hémorragie
 - C. L'infection
 - D. le syndrome de Kassabach-Merritt
 - E. le syndrome de Klippel-Trenaunay
13. Dans l'imperforation anale membraneuse :
- A. L'orifice anale et ectopique
 - B. l'orifice anal normalement situé est obturé par une membrane fine qui se bombe sous la pression du méconium
 - C. Selle avec aspect de crayons
 - D. une simple incision en croix permet l'évacuation du méconium
 - E. l'orifice anale est obturé incomplètement par un diaphragme muqueux
14. Invagination intestinale :
- A. C'est plus fréquent chez les nourrissons
 - B. détermine une occlusion intestinale mécanique
 - C. représente la pénétration d'un segment intestinale par une fente du mésentère
 - D. c'est plus fréquent chez le nouveau-né
 - E. représente le télescopage de l'anse intestinale supra jacente dans l'anse sous-jacente

15. Hernie inguinale :
- A. Peut produire une nécrose testiculaire par compression sur le cordon spermatique
 - B. est plus fréquent chez les femelles
 - C. l'étranglement est la complication la plus courante
 - D. doit être opérée à la naissance
 - E. peut disparaître dans la première année
16. Hernie Diaphragmatique congénitale :
- A. Les formes tolérées peut-être diagnostiquées chez l'enfant plus âgé
 - B. c'est plus fréquents du côté droit
 - C. en l'absence de diagnostic précoce dans 70 % des cas de HD, le décès survient dans les 24-48 heures de vie
 - D. Présumer l'existence d'un défaut dans le diaphragme avec une hernie pulmonaire dans l'abdomen
 - E. présumer l'existence d'un défaut dans le diaphragme avec une hernie des viscères abdominaux dans le thorax
17. Le diagnostic de hernie inguinale est établi par :
- A. IRM de l'abdomen
 - B. La formation d'une tumeur herniaire est visible la réduction est pratiquée en taxis
 - C. examen clinique de la région de l'aîne
 - D. palpation pendant l'effort de toux
 - E. radiographie
18. Le diagnostic différentiel de la fracture obstétricale de la clavicule se fait avec :
- A. Fracture obstétricale du fémur
 - B. ostéo arthrite septique périnatale
 - C. paralysie du plexus brachial
 - D. fracture obstétricale de l'humérus
 - E. insuffisance motrices d'origine centrale
19. Hydrocel :
- A. C' est causée par l'accumulation de sang dans la vaginale testiculaire
 - B. Est une formation kystique contenant du liquide clair si tu es dans un reste de canal péritonéo vaginale
 - C. apparaît par une dilatation des veines spermatique
 - D. Est non douloureuse à la palpation
 - E. peut disparaître spontanément jusqu'à l'âge de 1 ans
20. Reflux vésico-urétéral (VUR) :
- A. Le patient peut présenter des signes d'infection urinaire : pollakiurie, hématurie, pyurie
 - B. est causée par une obstruction dans la voie d'évacuation de l'urine du niveau urétéral supérieur
 - C. peut-être causé par une perturbation du mécanisme physiologique de la jonction urétéro vésicale
 - D. est fréquemment associée à des signes d'infection respiratoire aiguë
 - E. Les cas graves peuvent présenter des manifestations d'insuffisance rénale chronique
21. L'évolution des hémangiomes :
- A. Sous des formes étendue en 3-4 mois peut envahir des zones considérables
 - B. la plupart croissent rapidement après l'âge d'un an
 - C. ils peuvent disparaître en quelques mois ou jusqu'à 5-6 ans
 - D. la plupart grandissent proportionnellement à l'enfant
 - E. c'est prévisible

22. Cliniquement dans l'appendicite aiguë nous rencontrons :
- A. Douleur localisée péri-ombilical
 - B. myalgie gastrocnémienne
 - C. douleur dans la fosse iliaque droite
 - D. la douleur peut s'atténuer spontanément en face d'appendicite gangréneuse et réapparaître de façon brusque au moment de la perforation
 - E. vomissement unique ou répéter apparaît surtout au début de l'affection dans plus de 90 % des cas
23. Le traitement de la fracture obstétricale de la clavicule implique :
- A. Réduction fermée par une traction douce
 - B. bandage doux de type Dassault pendant 14 jours
 - C. immobilisation plâtrée du membre atteint en position de "salut militaire"
 - D. l'immobilisation plâtrée de type Dassault pendant 4 semaines
 - E. les fractures obstétricales qui, au moment du diagnostic, présente le cal osseux ne nécessite plus de traitement orthopédique
24. Les déclarations suivantes concernant les hypospadias sont fausses :
- A. Dans les hypospadias penoscrotales et scrotales, les testicules sont généralement situées dans les bourses scrotales homolatérales
 - B. le traitement de l'hypospadias est organisé en fonction de la forme anatomo pathologique et de l'âge de l'enfant
 - C. l'hypospadias périnéale est la forme la plus facile à traiter
 - D. dans les hypospadias balaniques, le flux urinaire est normal
 - E. dans les hypospadias, l'urétroplastie est réalisée après une seule intervention vers l'âge de 2 ans
25. Les déclarations suivantes concernant les hypospadias sont vraies :
- A. L'hypospadias est causée par la résorption de la lame urétrale du tubercule génital et par le d'union des plis génitaux (dysraphisme) dans le sinus urogénital
 - B. l'hypospadias balanique est la forme la plus bénigne et la plus fréquente
 - C. dans les hypospadias, il existe différents degrés de torsion latérale du pénis
 - D. l'hypospadias est l'ouverture de l'urètre dans le pénis dorsal
 - E. Dans les hypospadias penoscrotales et scrotales, le méat urinaire s'ouvre au niveau du périnée antérieure sur la ligne ano-scrotale
26. Le traitement préopératoire dans l'omphalocèle comprend :
- A. radiographie thoracique, ECG, analyses de laboratoire
 - B. positionnement le nouveau-né en décubitus ventral
 - C. protections de l'omphalocèle avec des compresses imbibées dans un sérum physiologique chaud
 - D. sonde naso-gastrique et rectale pour prévenir la distension du tube digestif
 - E. une naissance par césarienne si le diagnostic prénatal est connu
27. Les déclarations suivantes concernant les hypospadias sont vraies :
- A. L'urétropropastie est réalisée après une seule procédure à l'âge de 6-7 ans
 - B. Les objectifs du traitement de l'hypospadias visent à retrouver la forme du pénis et a réaliser un néo-urètre afin d'obtenir des mictions physiologiques des érections et des éjaculations
 - C. la correction des vices morphologiques du pénis a lieu vers l'âge de 2 ans
 - D. le recalibrage du méat hypospadiques sténotique se fait à l'adolescence
 - E. il est conseillé de terminer le traitement jusqu'à l'âge de la scolarité afin de diminuer les complexes mentaux de ces enfants qui peuvent être accentuées une fois entrée dans la communauté

28. Les symptômes présents dans la hernie inguinale étranglée sont :
- A. douleur
 - B. selles diarrhéiques et hémorragiques
 - C. vomissements
 - D. tumeurs inguinales
 - E. hématomène
29. Le reflux vésico-urétéral peut être causé par :
- A. contraction intra-vésicale de l'uretère
 - B. syndrome de Prune-Belly
 - C. Dissidence de Marion (hypertrophie du col vésical)
 - D. Raccourcir une/ou une immaturité de l'uretère intravésical
 - E. Valvules urétrales postérieures
30. Traitement de la hernie inguinale :
- A. est principalement médical
 - B. ne nécessite pas de procédures pour renforcer la paroi abdominale
 - C. est chirurgical
 - D. chez les filles, l'ancrage du pilier péritonéal au tendon conjonctif est pratique (procédure Barker)
 - E. peut être atteint à tout âge
31. Les formes anatomopathologiques des hémangiomes sont :
- A. hémangiomatose diffuse
 - B. hémangiome intradermique ou plan "tache de vin"
 - C. hémangiome caverneux
 - D. malformation artério-veineuse
 - E. hémangiome tuberculeux
32. saignement (hémorragie) par diverticule iléal de Meckel :
- A. est accompagné par coliques abdominales
 - B. dans les petits saignements répétés se modifie la couleur des selles sans en modifier la consistance
 - C. se produit par ulcération de la muqueuse iléale adjacente aux îlots de muqueuse gastrique sécrétante
 - D. dans les saignements abondants et répétés se modifie autant la couleur que la consistance des selles et survient des signes de choc hypovolémique
 - E. le saignement est sans douleur
33. L'évolution d'un patient souffrant de reflux vésico-urétéral peut avoir lequel de ces scénarios :
- A. les infections urinaires n'apparaissent pas de manière unilatérale
 - B. le reflux de bas grade chez le nouveau-né peut évoluer avec une rémission spontanée
 - C. l'atrophie rénale est secondaire à la haute pression de reflux exercée sur le parenchyme rénal
 - D. les infections urinaires peuvent être récurrentes
 - E. le reflux bilatéral ne provoque pas d'insuffisance rénale chronique
34. Parmi les examens d'imagerie utilisés dans la fracture obstétricale de la clavicule
- A. tous les nouveau-nés d'un accouchement difficile bénéficient d'une radiographie thoracique parce que la plupart présente habituellement une fracture obstétricale
 - B. si la fracture est détectée tardivement, la radiographie révèle un callus hypertrophique
 - C. la radiographie révèle souvent une fracture en bois vert
 - D. IRM est souvent utilisée pour détecter une fracture de la clavicule chez le nouveau-né car il est non invasif
 - E. la radiographie n'est pas utile dans le diagnostic à cet âge parce que la clavicule n'est pas ossifiée chez 50% des nouveau-nés à la naissance

35. Le mégacôlon congénital se manifeste par :
- A. Absence de transit intestinal
 - B. distension abdominale progressive
 - C. boulimie
 - D. vomissement alimentaire au début puis bilieux et ultérieurement fécaloïde
 - E. épisode de diarrhée paradoxale avec émission de selles molles malodorantes
36. Traumatismes obstétricaux :
- A. sont causées par une disproportion entre les dimensions du fœtus et la filière plus étroite du bassin maternelle
 - B. aucune réponse n'est pas correcte
 - C. sont causés par la position fœtale anormale
 - D. sont plus fréquentes à la première naissance
 - E. ils n'ont jamais un risque vital
37. Traitement des défauts labiaux et palatins
- A. défauts de palais sont corrigés à l'âge de 18-24 mois
 - B. défauts de palais sont corrigés à 6 mois et de la lèvre 18-24 mois
 - C. formes simples de fente labiale s'opèrent à 6-8 mois après la naissance
 - D. les cas de fente labiale complète s'opèrent à l'âge de 6 mois
 - E. formes simples de fente labiale s'opèrent à 2-3 mois après la naissance
38. Le diagnostic différentiel de la hernie inguinale se fait avec :
- A. cryptorchidie ou testicules ectopiques
 - B. formation des tumeurs abdominales
 - C. kyste du cordon Nuck (la petite fille)
 - D. hydrocèle vaginale
 - E. appendicite aiguë
39. Traitement du kyste du canal thyroïdienne :
- A. consiste en la résection du tout le trajet fistuleux jusqu'à la base de la langue
 - B. comporte la résection de la partie centrale d'os hyoïde
 - C. est chirurgical et se pratique après l'arrêt du processus inflammatoire
 - D. est chirurgical et se pratique au cours du processus inflammatoire
 - E. il est strictement médical

QCM 1 : À propos de l'étiopathogénie des fentes labio-palatines, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Les facteurs environnementaux sont la seule cause.
- B. Les anomalies peuvent être isolées ou associées à des syndromes.
- C. L'exposition aux radiations est un facteur de risque environnemental.
- D. Il n'existe aucun facteur génétique connu
- E. La consommation excessive d'alcool pendant la grossesse est un facteur de risque.

QCM 2 : Concernant le traitement chirurgical des fentes labio-palatines, indiquez les propositions exactes :

- A. La réparation de la lèvre se fait à 10 ans.
- B. La greffe osseuse alvéolaire est réalisée vers 7-9 ans.
- C. La correction de la fente palatine intervient avant 1 an.
- D. Les ostéotomies maxillaires/mandibulaires se font à 5 ans.
- E. La "règle du 10" s'applique au début de la correction chirurgicale.

QCM 3 : Quelle est la forme la plus sévère de fente labiale mentionnée dans le texte ?

- A. Fente labiale unilatérale incomplète (« bec de lièvre »)
- B. Fente labiale bilatérale incomplète
- C. Fente labiale bilatérale complète
- D. Fente palatine isolée
- E. Fente labiale médiane simple

QCM 4 : À propos du kyste du canal thyroglosse, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Il résulte de la persistance du canal thyroglosse.
- B. Il est généralement douloureux dès sa formation.
- C. Il est mobile lors de la protrusion de la langue.
- D. Il survient uniquement chez l'adulte.
- E. Il peut parfois s'enflammer et fistuliser.

QCM 5 : Concernant le traitement du kyste du canal thyroglosse, indiquez les propositions exactes :

- A. Il repose sur une exérèse simple du kyste sans retirer d'os.
- B. L'ablation doit inclure une portion de l'os hyoïde.
- C. La chirurgie doit être réalisée pendant une poussée inflammatoire.
- D. La méthode de Sistrunk est la technique de référence.
- E. Une infection doit être traitée avant la chirurgie.

***QCM 6 : Quelle est la complication la plus grave du kyste du canal thyroïdienne s'il n'est pas excisé ?**

- A. Hémorragie sévère
- B. Transformation en carcinome papillaire thyroïdien
- C. Rupture dans la cavité orale
- D. Survenue d'une thyroïdite chronique
- E. Ankylose de la langue

QCM 7 : Concernant les kystes et fistules des arcs branchiaux, lesquelles de ces affirmations sont correctes ?

- A. Ils résultent d'une résorption excessive des arcs branchiaux.
- B. Les anomalies du deuxième arc branchial sont les plus fréquentes.
- C. Le diagnostic repose principalement sur la biopsie systématique.
- D. Les kystes peuvent être mobiles et indolores.
- E. Une fistulisation cutanée est généralement congénitale.

QCM 8 : À propos du traitement des kystes et fistules branchiaux, quelles affirmations sont justes ?

- A. L'excision doit être faite en présence d'une inflammation pour repérer plus facilement le trajet fistuleux.
- B. Le traitement est exclusivement chirurgical.
- C. Une incision transversale en étages est utilisée pour un meilleur résultat esthétique.
- D. La dissection doit éviter d'approcher la fistule pour minimiser les risques.
- E. Toute la fistule, jusqu'au pharynx, doit être retirée.

***QCM 9 : Où se situent généralement les kystes et fistules dérivés du deuxième arc branchial ?**

- A. Au niveau du conduit auditif externe
- B. À proximité du nerf hypoglosse
- C. Sur le bord antérieur du muscle sternocléidomastoïdien
- D. Sous l'os hyoïde
- E. À la base de la langue

QCM 10 : Concernant les hémangiomes infantiles, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Ils apparaissent uniquement à l'âge adulte
- B. Ils prolifèrent rapidement puis régressent spontanément
- C. Ils sont plus fréquents chez les filles
- D. Ils sont systématiquement douloureux
- E. Ils concernent surtout la tête et le cou

QCM 11 : Concernant les malformations vasculaires, quelles propositions sont exactes ?

- A. Elles sont présentes à la naissance
- B. Elles prolifèrent rapidement comme les hémangiomes
- C. Elles peuvent être capillaires, veineuses, lymphatiques ou artérioveineuses
- D. Elles disparaissent souvent spontanément avant 7 ans
- E. Elles sont causées par des erreurs de développement embryonnaire

***QCM 12 : Quelle est actuellement la classification utilisée pour classer les anomalies vasculaires ?**

- A. Classification TNM
- B. Classification WHO
- C. Classification ISSVA
- D. Classification Bethesda
- E. Classification Dubois

QCM 13 : Concernant le Pectus Excavatum :

- A. C'est une déformation de la paroi thoracique antérieure.
- B. Il est plus fréquent chez les filles que chez les garçons.
- C. Il est souvent associé à une scoliose.
- D. La capacité thoracique est augmentée.
- E. L'origine est souvent génétique.

QCM 14 : À propos du traitement du Pectus Excavatum :

- A. La physiothérapie est systématiquement suffisante.
- B. La chirurgie de Nuss est une option de traitement efficace.
- C. Le traitement est toujours nécessaire, même pour les formes asymptomatiques.
- D. La chirurgie est idéalement réalisée à la puberté.
- E. Un corset thoracique est utilisé en première intention.

***QCM 15 : Quel est l'examen paraclinique de choix pour évaluer la sévérité d'un Pectus Excavatum?**

- A. Radiographie thoracique
- B. Scanner thoracique
- C. Échographie cardiaque
- D. Spirométrie
- E. Bilan biologique standard

QCM 16 : À propos de la hernie diaphragmatique congénitale :

- A. Elle empêche la séparation entre la cavité thoracique et abdominale.
- B. Elle est diagnostiquée en général après la naissance uniquement.
- C. Elle est plus fréquente à droite qu'à gauche.
- D. Elle peut s'accompagner d'hypoplasie pulmonaire.
- E. Elle est toujours isolée sans autres malformations associées.

QCM 17 : Concernant la prise en charge de la hernie diaphragmatique congénitale :

- A. L'ECMO peut être utilisée en préopératoire.
- B. L'alimentation orale est autorisée immédiatement après la naissance.
- C. L'intervention chirurgicale est une urgence immédiate juste après l'accouchement.
- D. Une intubation orotrachéale peut être nécessaire.
- E. Une laparotomie médiane sus-ombilicale est une approche possible.

***QCM 18 : Quel facteur est associé à un meilleur pronostic dans la hernie diaphragmatique congénitale ?**

- A. Présence du foie dans la cavité thoracique
- B. LHR élevé
- C. Diagnostic tardif
- D. Hypoplasie pulmonaire sévère
- E. Absence de traitement chirurgical

QCM 19 : À propos de l'atrésie de l'œsophage :

- A. Elle est toujours associée à une fistule trachéo-œsophagienne.
- B. Elle peut entraîner une hypersalivation chez le nouveau-né.
- C. Elle peut être associée au syndrome VACTERL.
- D. Son diagnostic anténatal est systématiquement posé par échographie.
- E. Son incidence est d'environ 1/3000-4000 naissances.

QCM 20 : Concernant le traitement de l'atrésie de l'œsophage :

- A. Il doit être réalisé d'urgence après la naissance.
- B. Le transport du nouveau-né peut attendre la confirmation radiologique définitive.
- C. La chirurgie classique utilise une thoracotomie extrapleurale droite.
- D. Si la distance entre les moignons œsophagiens est importante, une anastomose primaire est toujours réalisée.
- E. L'abord chirurgical peut aussi être thoracoscopique.

***QCM 21 : Quel élément est utilisé pour évaluer le pronostic des patients atteints d'atrésie de l'œsophage ?**

- A. Classification de Waterston
- B. Score d'Apgar
- C. Test de Guthrie
- D. Classification de Silverman
- E. Score de Ballard

QCM 22 : À propos de la sténose hypertrophique du pylore :

- A. Elle survient principalement chez les nourrissons de moins de 1 mois.
- B. Le sexe masculin est plus fréquemment affecté par rapport au sexe féminin.
- C. La cause exacte de la sténose hypertrophique du pylore est bien identifiée. *
- D. Des facteurs environnementaux, comme l'exposition à l'érythromycine, sont incriminés.
- E. Le tableau clinique peut inclure des vomissements bilieux explosifs.

QCM 23 : Concernant le diagnostic de la sténose hypertrophique du pylore :

- A. L'échographie abdominale est la méthode de diagnostic gold standard.
- B. L'examen au baryum est la méthode principale utilisée pour diagnostiquer la sténose.
- C. La palpation de l'olive pylorique est positive dans 70 à 90 % des cas.
- D. Le diagnostic peut être confirmé par la radiographie thoracique.
- E. Les vomissements sont souvent associés à des signes de déshydratation.

***QCM 24 : Quel est le traitement chirurgical de choix pour la sténose**

hypertrophique du pylore ?

- A. Résection pylorique.
- B. Pyloromyotomie extramuqueuse de Fredet.
- C. Gastrectomie partielle.
- D. Bypass gastro-intestinal.
- E. Endoscopie avec dilatation du pylore.

QCM 25 : Concernant l'atrésie du duodénum :

- A. L'atrésie du duodénum est une obstruction partielle du duodénum.
- B. Elle est souvent associée à d'autres malformations, comme le syndrome de Down.
- C. L'atrésie de type I est la moins fréquente, représentant environ 7 % des cas.
- D. L'incidence mondiale de l'atrésie du duodénum est estimée à 1 sur 6 000 à 10 000 naissances.
- E. La forme la plus fréquente d'atrésie du duodénum est l'atrésie de type II.

***QCM 26 : Quel type de malformation est le plus souvent associé à l'atrésie du duodénum ?**

- A. Syndrome de Marfan.
- B. Syndrome de Down.
- C. Spina bifida.
- D. Malformation de Chiari.
- E. Syndrome de Klinefelter.

QCM 27 : Concernant le diagnostic de l'atrésie du duodénum :

- A. Le signe radiologique de la « double bulle » est un indicateur clé.
- B. Un lavement baryté peut être utilisé pour exclure une malrotation intestinale.
- C. L'échographie cardiaque est rarement nécessaire dans ces cas.
- D. Le volume d'aspirat supérieur à 20 ml suggère une obstruction duodénale.
- E. Le diagnostic peut être posé dès la naissance sur la base de symptômes cliniques et radiologiques.

***QCM 28 : Quelle est la cause la plus fréquente d'obstruction intestinale chez les nouveau-nés ?**

- A. Atrésie du duodénum.
- B. Sténose du colostome.
- C. Atrésie et sténose intestinale.
- D. Hernie inguinale.
- E. Mégacôlon congénital.

QCM 29 : Concernant les types d'atrésie intestinale :

- A. L'atrésie de type I est la plus fréquente et ne touche que la muqueuse et la sous-muqueuse.
- B. L'atrésie de type II est causée par un cordon fibreux reliant le segment proximal dilaté et le segment distal rétréci.
- C. L'atrésie de type IIIa implique une boucle intestinale aveugle avec un mésentère en forme de "V".
- D. L'atrésie de type IIIb est souvent appelée "coque de pomme" et présente une configuration hélicoïdale de l'intestin.
- E. L'atrésie de type IV est une combinaison des types I et III.

QCM 30 : Quelles sont les causes possibles de l'atrésie intestinale ?

- A. Une lésion ischémique intra-utérine au niveau du mésentère.
- B. Une infection virale pendant la grossesse.
- C. Une perturbation vasculaire intra-utérine.
- D. Un volvulus ou une strangulation au cours du développement fœtal.
- E. Une mutation génétique.

***QCM 31 : Qu'est-ce qui caractérise la malrotation intestinale ?**

- A. Une perturbation du processus de rotation et de fixation de l'intestin fœtal.
- B. Une infection virale qui affecte la flore intestinale.
- C. Une obstruction du duodénum par un ligament de Ladd.
- D. Une malformation congénitale du côlon.
- E. Une torsion intestinale sans anomalie de la rotation.

QCM 32 : Quels sont les symptômes fréquents du volvulus intestinal ?

- A. Vomissements bilieux dès les premiers jours de vie.
- B. Distension abdominale rapide et progressive.
- C. Selles fécaloïdes et parfois sanguinolentes.
- D. Pleurs déchirants et absence de transit intestinal.
- E. Présence de douleurs thoraciques aiguës.

QCM 33 : Les formes anatomiques de malrotation intestinale comprennent :

- A. Absence de rotation, où l'intestin grêle se situe dans l'hémiabdomen droit.
- B. Rotation complète de 360°, entraînant une torsion de l'intestin.
- C. Rotation incomplète avec le cæcum situé sur la ligne médiane.
- D. Rotation inversée de 90°.
- E. Rotation complète suivie d'un ancrage défectueux du mésentère.

QCM 34 : Quels sont les symptômes caractéristiques du mégacolon congénital chez le nouveau-né

?

- A. Libération retardée du méconium dans les 24-48 premières heures.
- B. Distension abdominale progressive.
- C. Vomissements bilieux, puis fécaloïdes.
- D. Selles fréquentes et normales dès les premiers jours.
- E. Entérocolite agressive, évoluant vers un sepsis grave.

***QCM 35 : Quel examen paraclinique est de choix pour diagnostiquer le mégacolon congénital ?**

- A. IRM abdominale.
- B. Tomodensitométrie (scanner).
- C. Irrigoclysmie.
- D. Échographie abdominale.
- E. Biopsie rectale.

QCM 36 : Quels traitements peuvent être nécessaires en cas de mégacolon congénital ?

- A. Lavements rectaux répétés pour décompresser le côlon.
- B. Colostomie temporaire si les lavements sont inefficaces.
- C. Traitement médical uniquement sans chirurgie.
- D. Résection chirurgicale du segment aganglionique du côlon.
- E. Antibiothérapie préventive pour les infections abdominales.

QCM 37 : Quelles sont les anomalies fréquemment associées aux malformations anorectales ?

- A. Anomalies génitales.
- B. Anomalies rénales.
- C. Anomalies cardiaques.
- D. Malformations pulmonaires.
- E. Cryptorchidie et hypospadias.

***QCM 38 : Quel examen d'imagerie est le plus important pour diagnostiquer les malformations anorectales ?**

- A. Échographie abdominale.
- B. Radiographie thoracique.
- C. Invertogramme.
- D. IRM abdominale.
- E. Scanner avec agent de contraste.

QCM 39 : Quels sont les traitements possibles pour les malformations anorectales ?

- A. Anorectoplastie pour les malformations basses.
- B. Colostomie pour les malformations hautes ou pour les patients en état critique.
- C. Traitement médical sans chirurgie.
- D. Anorectoplastie en période néonatale pour les malformations hautes.
- E. Chirurgie du côlon à un an.

QCM 40 : Quels sont les facteurs favorables au développement de laparoschisis ?

- A. Âge maternel inférieur à 20 ans.
- B. Tabagisme.
- C. Médicaments vasodilatateurs.
- D. Médicaments vasoconstricteurs.
- E. Consommation excessive de café.

***QCM 41 : Quel est le principal traitement chirurgical pour le laparoschisis ?**

- A. Anorectoplastie.
- B. Réintégration des anses intestinales dans la cavité abdominale et fermeture de la paroi abdominale.
- C. Résection de l'intestin hernié.
- D. Colostomie.
- E. Transplantation d'intestin.

QCM 42 : Quels examens peuvent être utilisés pour diagnostiquer le laparoschisis ?

- A. Échographie prénatale à 18-20 semaines.
- B. Radiographie thoracique.
- C. Alpha-foetoprotéine élevée.
- D. Inspection clinique à la naissance.
- E. Invertogramme.

QCM 43 : Quelles sont les caractéristiques de l'omphalocèle ?

- A. Le sac est recouvert d'une membrane avasculaire et translucide.
- B. Le défaut abdominal est généralement situé à gauche de l'abdomen.
- C. Le contenu du sac est souvent constitué des intestins et du foie.
- D. La membrane recouvrant le sac est composée de 2 couches : péritoine et membrane amniotique.
- E. Le cordon ombilical est inséré au niveau du défaut.

***QCM 44 : Quel examen prénatal permet d'établir le diagnostic d'omphalocèle dès la 18ème semaine de gestation ?**

- A. Radiographie thoracique.
- B. Échographie 2D.
- C. Amniocentèse.
- D. IRM.
- E. Échographie cardiaque.

QCM 45 : Quels sont les traitements possibles de l'omphalocèle ?

- A. Excision de la membrane et réintégration progressive des viscères dans la cavité abdominale.
- B. Fermeture immédiate du défaut sans évaluation préalable.
- C. Utilisation de la technique de Fufezan pour la réintégration des viscères.
- D. Traitement conservateur si des malformations graves empêchent une anesthésie générale.
- E. Résection complète des viscères herniés.

QCM 47 : Quelles sont les caractéristiques de la hernie inguinale ?

- A. La hernie inguinale directe est plus courante chez les enfants que la hernie inguinale indirecte.
- B. La hernie inguinale chez les hommes peut devenir visible dès le premier cri, notamment chez les prématurés.
- C. Les hernies fémorales représentent plus de 50 % des hernies inguinales pédiatriques.
- D. La hernie inguinale est plus fréquente chez les hommes, avec un ratio de 10:1.
- E. Les hernies inguinales sont toujours unilatérales chez les nourrissons.

***QCM 48 : Quel est le traitement indiqué pour une hernie inguinale ?**

- A. Médication par anti-inflammatoires.
- B. Traitement chirurgical avec ligature du canal péritonéo-vaginal à la base.
- C. Surveillance uniquement, sans intervention.
- D. Traitement par radiothérapie.
- E. Traitement conservateur avec antibiotiques.

QCM 49 : Quels sont les symptômes de la hernie inguinale étranglée chez les nourrissons ?

- A. Douleurs avec des pleurs et une agitation inhabituels.
- B. Vomissements entraînant une déshydratation.
- C. Présence d'une tumeur de l'aîne avec une consistance ferme et douloureuse.
- D. Réduction spontanée de la hernie pendant le sommeil.
- E. Augmentation de la taille de la hernie lors de la miction.

QCM 50 : Quelles sont les caractéristiques de la hernie ombilicale ?

- A. Elle est formée uniquement de péritoine et de peau.
- B. Elle est fréquente chez la population pédiatrique afro-américaine, avec une incidence d'environ 50%.
- C. Elle se ferme spontanément chez tous les enfants.
- D. Le risque d'incarcération est élevé.
- E. Les symptômes cliniques sont généralement absents.

QCM 51 : Quel est le traitement de la hernie ombilicale ?

- A. La chirurgie est recommandée si la hernie persiste après 4 ans.
- B. Si le défaut est supérieur à 1,5 cm à 2 ans, une fermeture spontanée est probable.
- C. L'incarcération de l'épiploon peut être une indication de chirurgie précoce.
- D. Le traitement consiste toujours en une surveillance sans intervention chirurgicale.
- E. Une ombilicoplastie peut être réalisée lors de la réparation du défaut.

***QCM 52 : A quel âge la hernie ombilicale se ferme généralement spontanément ?**

- A. 1 an
- B. 3 à 4 ans
- C. 5 à 6 ans
- D. 7 à 8 ans
- E. 10 ans

QCM 53 : Quels sont les types de testicules associés à la cryptorchidie ?

- A. Testicule non palpable, caché, situé intra-abdominalement.
- B. Testicule rétractile, situé au niveau de l'orifice externe du canal inguinal.
- C. Testicule flottant, se retrouvant spontanément dans la bourse scrotale.
- D. Testicule palpable mais non mobilisable par traction au niveau du scrotum.
- E. Testicule absent, ce qui correspond à une anorchidie.

QCM 54 : Quels sont les traitements possibles pour la cryptorchidie ?

- A. Le traitement chirurgical est recommandé dès l'âge de 12 à 18 mois.
- B. La laparoscopie exploratoire est souvent utilisée lorsque le testicule n'est pas palpable.
- C. L'approche combinée inguinale et scrotale est utilisée si le testicule est palpable le long du canal inguinal.
- D. Les médicaments hormonaux sont utilisés pour forcer la descente du testicule.
- E. Le traitement consiste uniquement en une surveillance sans intervention chirurgicale.

***QCM 55 : Quel est le pronostic de la cryptorchidie si elle n'est pas traitée correctement ?**

- A. Le pronostic est favorable, sans complications.
- B. La cryptorchidie peut causer des dysplasie testiculaire mais sans impact sur la fertilité.
- C. Elle peut entraîner une infertilité masculine et d'autres complications graves.
- D. Il n'y a pas de risque de complications si elle est laissée sans traitement.
- E. La cryptorchidie devient toujours asymptomatique avec l'âge.

QCM 56 : Quelles sont les causes principales de scrotum aigu ?

- A. Torsion testiculaire.
- B. Torsion de l'hydatide de Morgagni.
- C. Hernie inguinale étranglée.
- D. Traumatismes scrotaux et testiculaires.
- E. Infection urinaire.

QCM 57 : Quels sont les éléments diagnostiques importants pour la torsion testiculaire ?

- A. La douleur violente et continue, souvent nocturne.
- B. L'augmentation de volume et l'œdème du scrotum.
- C. Le testicule ascensionné vers la partie supérieure du scrotum.
- D. La possibilité d'une torsion manuelle avant intervention chirurgicale.
- E. La présence d'une masse palpable dans l'abdomen.

***QCM 58 : Quel est le traitement principal pour une torsion testiculaire non résolue par détorsion manuelle ?**

- A. Traitement conservateur, avec suivi.
- B. Exploration chirurgicale et orchiectomie si le testicule est non viable.
- C. Utilisation de médicaments anti-inflammatoires uniquement.
- D. Antalgiques et observation sans intervention chirurgicale.
- E. Radiothérapie pour préserver la fonction testiculaire.

QCM 59 : Quelles sont les causes possibles de la stase sanguine dans la varicocèle ?

- A. Passage de la veine rénale gauche par la pince aorto-mésentérique.
- B. La présence de valvules unidirectionnelles dans la veine spermatique gauche.
- C. Spasme du segment distal de la veine spermatique dû au reflux sanguin provenant de la glande surrénale.
- D. La grande longueur de la veine spermatique gauche.
- E. L'absence de veines dilatées dans la veine rénale gauche.

QCM 60 : Quels sont les examens paracliniques recommandés pour le diagnostic de la varicocèle ?

- A. Echographie abdominale.
- B. Phlébographie spermatique.
- C. Biopsie testiculaire.
- D. Test de spermatogenèse par échographie Doppler.
- E. Spermogramme.

***QCM 61 : Quel est le traitement chirurgical pour la varicocèle ?**

- A. Ligature des veines spermatiques dilatées.
- B. Sclérothérapie des veines rénales.
- C. Ablation du testicule affecté.
- D. Observation et traitement médical.
- E. Radiothérapie pour réduire les varices.

QCM 62 : Quelles sont les causes possibles de la torsion ovarienne ?

- A. Kyste ovarien ou tumeur annexielle.
- B. Un ovaire normal, sans pathologie préexistante.
- C. Une grossesse extra-utérine.
- D. Un fibrome utérin.
- E. Une infection pelvienne.

QCM 63 : Quels sont les signes cliniques associés à la torsion ovarienne ?

- A. Douleur violente, localisée dans le bas-ventre, irradiant parfois vers l'aîne et les flancs.
- B. Fièvre élevée et frissons.
- C. Tachycardie et position antalgique.
- D. Nausées, vomissements et constipation.
- E. Sensibilité douloureuse dans le bas-ventre avec défense musculaire.

***QCM 64 : Quel est l'examen paraclinique essentiel pour diagnostiquer une torsion ovarienne ?**

- A. Echographie abdominale.
- B. Tomodensitométrie abdomino-pelvienne.
- C. Spermogramme.
- D. Radiographie abdominale.
- E. Test de grossesse.

QCM 65 : Quelles sont les caractéristiques de l'invagination intestinale ?

- A. Il s'agit d'une forme d'occlusion intestinale mécanique.
- B. L'invagination se produit lorsque l'anse intestinale inférieure pénètre dans l'anse sus-jacente.
- C. Elle est plus fréquente chez les nourrissons âgés de 4 à 10 mois.
- D. Les filles sont plus souvent touchées que les garçons.
- E. L'invagination intestinale est rare chez les enfants de moins de 4 mois.

QCM 66 : Quels sont les facteurs étiopathogéniques de l'invagination intestinale primaire ?

- A. Croissance anormale de la région caecocolique par rapport à l'intestin grêle.
- B. Infection virale saisonnière provoquant une entérocolite.
- C. L'absence d'acollisation du caecocolique ascendant au péritoine pariétal postérieur.
- D. La présence d'une tumeur intestinale.
- E. Un corps étranger dans le tube digestif.

***QCM 67 : Quel est le principal examen paraclinique pour diagnostiquer une invagination intestinale ?**

- A. Échographie abdominale.
- B. Radiographie abdominale avec contraste.
- C. Tomodensitométrie.
- D. Endoscopie digestive haute.
- E. IRM abdominale.

QCM 68 : Quels sont les symptômes caractéristiques de l'iléus méconial simple ?

- A. Absence d'émission de méconium dans les 24-48 premières heures.
- B. Vomissements bilieux.
- C. Rétrécissement de l'anus et du rectum.
- D. Diarrhée avec mucus.
- E. Coliques abdominales intenses.

QCM 69 : Quelles sont les complications possibles de l'iléus méconial compliqué ?

- A. Péritonite méconiale.
- B. Perforation intestinale.
- C. Ascite méconiale.
- D. Diarrhée aiguë.
- E. Kystes biliaires.

***QCM 70 : Quel est le traitement de l'iléus méconial non compliqué ?**

- A. Chirurgie immédiate.
- B. Irrigation intestinale avec un produit de contraste hydrosoluble.
- C. Antibiothérapie intraveineuse.
- D. Résection intestinale.
- E. Réhydratation uniquement.

QCM 71 : Quelles sont les causes possibles de l'obstruction de la lumière appendiculaire dans l'appendicite aiguë ?

- A. Coprolithes.
- B. Corps étrangers.
- C. Obstruction des voies urinaires.
- D. Cicatrices et adhérences.
- E. Infection virale.

QCM 72 : Quelles sont les caractéristiques cliniques de l'appendicite aiguë ?

- A. Douleur initialement localisée au niveau périombilical.
- B. Douleur migrante vers la fosse iliaque droite.
- C. Diarrhée et perte d'appétit.
- D. Vomissements après la douleur.
- E. Selles sanglantes.

***QCM 73 : Quel est le principal traitement chirurgical de l'appendicite aiguë ?**

- A. Appendicectomie.
- B. Antibiotiques parentéraux.
- C. Résection du côlon.
- D. Drainage du péritoine.
- E. Laparotomie pour réparation intestinale.

QCM 74 : Quelles sont les causes possibles de symptômes chez une personne ayant un diverticule de Meckel ?

- A. Hémorragie due à un ulcère muqueux.
- B. Perforation du diverticule.
- C. Infection virale.
- D. Occlusion intestinale par invagination ou volvulus.
- E. Douleur abdominale chronique sans autre symptôme.

QCM 75 : Quelles complications peuvent résulter du diverticule de Meckel chez l'enfant ?

- A. Hémorragie digestive basse.
- B. Péritonite secondaire due à perforation.
- C. Constipation sévère.
- D. Diverticulite de Meckel.
- E. Perforation gastrique.

***QCM 76 : Quel est le principal traitement pour le diverticule de Meckel ?**

- A. Traitement antibiotique à large spectre.
- B. Résection chirurgicale du diverticule.
- C. Radiothérapie pour réduire la taille du diverticule.
- D. Résection du côlon.
- E. Traitement médical de la douleur.

QCM 77 : Quelles sont les caractéristiques cliniques communes chez les enfants atteints de néphroblastome ?

- A. Masse tumorale abdominale asymptomatique.
- B. Hématurie dans 20 % des cas.
- C. Hyperplasie bénigne des reins.
- D. Douleurs abdominales dues à une rupture intratumorale.
- E. Hypertension due à l'activation du système rénine-angiotensine.

***QCM 78 : Quel est le principal traitement pour le néphroblastome ?**

- A. Chirurgie seule.
- B. Chimio- et radiothérapie.
- C. Traitement médical sans chirurgie.
- D. Traitement combiné incluant la chirurgie, la chimiothérapie et parfois la radiothérapie.
- E. Résection par laparoscopie uniquement.

QCM 79 : Quels sont les risques de complications postopératoires après un traitement pour néphroblastome ?

- A. Infection.
- B. Saignements.
- C. Invagination iléo-iléale dans 10 % des cas.
- D. Insuffisance rénale aiguë chez tous les patients.
- E. Tumeur maligne secondaire à un taux de 1,6 %.

QCM 80 : Quels symptômes peuvent être associés au neuroblastome chez les enfants ?

- A. Douleurs osseuses.
- B. Constipation ou rétention urinaire.
- C. Diarrhée aqueuse abondante.
- D. Pertes de cheveux massives.
- E. Bouffées vasomotrices et transpiration excessive.

QCM 81 : Quels examens sont utilisés pour le diagnostic du neuroblastome ?

- A. Radiographie thoracique.
- B. Échographie.
- C. TDM (Tomodensitométrie).
- D. Test de dépistage du diabète.
- E. IRM (Imagerie par Résonance Magnétique).

***QCM 82 : Quelle est la survie des patients atteints de neuroblastome à faible risque ?**

- A. Inférieure à 30 %.
- B. Supérieure à 50 %.
- C. Supérieure à 98 %.
- D. Entre 60 % et 80 %.
- E. Entre 90 % et 95 %.

QCM 83 : Quelles sont les caractéristiques des tératomes ?

- A. Ils peuvent contenir des tissus de nature différente.
- B. Ils sont toujours bénins.
- C. Ils peuvent être solides ou kystiques.
- D. Ils se développent généralement sur la ligne médiane du corps.
- E. Leur étiopathogénie est liée à des cellules germinales primordiales totipotentes.

QCM 84 : Quels sont les traitements associés aux tératomes ?

- A. La résection chirurgicale des tératomes bénins est généralement curative.
- B. La chimiothérapie est toujours utilisée après une résection chirurgicale.
- C. La chirurgie est accompagnée d'une radiothérapie dans tous les cas.
- D. L'excision des tératomes immatures nécessite une chimiothérapie adjuvante.
- E. L'ovariectomie est le traitement standard des tératomes ovariens bénins.

***QCM 85 : Quel est le pronostic des tératomes, en particulier ceux qui sont bénins ?**

- A. Leur pronostic est généralement favorable, avec plus de 90 % de survie à 5 ans.
- B. Leur pronostic est mauvais, avec moins de 50 % de survie à 5 ans.
- C. Ils entraînent des récidives fréquentes même après une chirurgie complète.
- D. Leur pronostic est modéré, avec 60 % de survie à 5 ans.
- E. Ils ne nécessitent jamais de suivi postopératoire.

QCM 86 : Quels sont les sous-types histologiques des rhabdomyosarcomes ?

- A. Embryonnaire
- B. Alvéolaire
- C. Pléomorphe
- D. Carcinomateux
- E. Sarcomateux

QCM 87 : Quels symptômes sont associés aux rhabdomyosarcomes ?

- A. Masse tumorale évidente dans la région touchée.
- B. Douleur abdominale intense dans la région pelvienne.
- C. Symptômes urinaires comme l'hématurie, fréquence et rétention urinaire dans les tumeurs de la vessie et de la prostate.
- D. Saignements et écoulements dans les tumeurs vaginales.
- E. Tumeurs botryoïdes visibles dans le scrotum.

***QCM 88 : Quel est le taux de survie à 5 ans des tumeurs à faible risque dans le rhabdomyosarcome ?**

- A. Moins de 50 %
- B. 55 à 70 %
- C. Plus de 90 %
- D. 60 %
- E. Moins de 60 %

QCM 89 : Quels sont les facteurs de risque associés à l'hépatoblastome chez l'enfant ?

- A. Syndrome de Beckwith-Weidemann
- B. Polypose adénomateuse familiale
- C. Nourrissons prématurés
- D. Maladies hépatiques chroniques
- E. Cancer du poumon

***QCM 90 : Quelle est la principale caractéristique du carcinome hépatocellulaire chez l'enfant ?**

- A. Il est principalement diagnostiqué avant l'âge de 3 ans.
- B. Il est fréquent chez les nourrissons prématurés.
- C. Il se manifeste souvent par une rupture intrapéritonéale dans environ 10 % des cas.
- D. Il a une très bonne réponse à la chimiothérapie seule.
- E. Il est plus fréquent dans les foies non cirrhotiques.

QCM 91 : Parmi les tumeurs qui peuvent métastaser au foie, lesquelles sont mentionnées dans le texte ?

- A. Neuroblastome
- B. Tumeur de Wilms
- C. Carcinome hépatocellulaire
- D. Ostéosarcome
- E. Lymphome

QCM 92 : Quels sont les facteurs qui influencent l'évaluation et la prise en charge des traumatismes pédiatriques ?

- A. Les différences anatomiques entre les enfants et les adultes
- B. La réponse physiologique des enfants face à un traumatisme majeur
- C. Le niveau de stress des parents
- D. Le statut socio-économique de l'enfant
- E. La formation des professionnels de santé

QCM 93 : Quelles sont les étapes de l'évaluation primaire d'un enfant polytraumatisé selon la séquence « ABCDE » ?

- A. A : Voies aériennes (Airway)
- B. C : Circulation
- C. D : Digestion
- D. E : Exposition (Exposure)
- E. B : Bilans biologiques

***QCM 94 : Quel est le principal signe clinique d'une obstruction partielle des voies aériennes supérieures chez l'enfant ?**

- A. Cyanose généralisée
- B. Stridor inspiratoire
- C. Respiration bruyante
- D. Fréquence cardiaque élevée
- E. Halètement

QCM 95 : Quelles sont les particularités anatomiques de la cage thoracique chez l'enfant qui la rendent plus vulnérable aux blessures thoraciques ?

- A. Une cage thoracique rigide et peu élastique.
- B. Un médiastin plus large que chez l'adulte.
- C. Une faible masse musculaire protectrice.
- D. Un diamètre transversal des voies aériennes plus grand.
- E. Une trachée plus longue que chez l'adulte.

QCM 96 : Quelles sont les méthodes de traitement des lésions thoraciques suivantes ?

- A. Pour un volet costal, la fixation de la fracture est toujours nécessaire.
- B. L'asphyxie traumatique peut être traitée par ventilation en pression positive et tonicité cardiaque.
- C. L'hémothorax nécessite une ponction pleurale dans tous les cas.
- D. Le pneumothorax nécessite souvent un drainage rapide s'il est de type pneumothorax valvulaire.
- E. La contusion pulmonaire se traite uniquement par chirurgie.

***QCM 97 : Quelle est la principale caractéristique du traitement d'un hémothorax ?**

- A. Une ponction pleurale est toujours effectuée dans les premières 24 heures.
- B. Le traitement repose exclusivement sur des antibiotiques.
- C. Il faut généralement une intervention chirurgicale en cas d'hémorragie massive.
- D. Une radiographie thoracique est inutile pour poser le diagnostic.
- E. Les hémothorax modérés ne nécessitent aucun traitement.

QCM 98 : Quelles sont les causes les plus fréquentes des traumatismes abdominaux chez les enfants ?

- A. Chutes de vélo
- B. Guidons de vélo
- C. Accident de voiture
- D. Traumatismes par arme blanche
- E. Traumatismes par arme à feu

QCM 99 : Quels sont les signes cliniques dominants du syndrome d'hémorragie interne ?

- A. Peau pâle
- B. Agitation psychomotrice
- C. Soif intense
- D. Hypotension
- E. Défense musculaire

***QCM 100 : Quelles méthodes sont couramment utilisées pour diagnostiquer un traumatisme hépatique ?**

- A. Échographie abdominale (FAST)
- B. Radiographie abdominale simple
- C. Tomodensitométrie (TDM)
- D. Examen rectal
- E. Scanner thoracique

QCM 101 : Quels sont les principaux mécanismes responsables des traumatismes rénaux ?

- A. Contusions dues à des accidents de la route
- B. Plaies pénétrantes fréquentes chez les enfants
- C. Lésions iatrogènes durant des interventions médicales
- D. Fractures de côtes
- E. Chutes de hauteur

QCM 102. Parmi les options suivantes, lesquelles correspondent au traitement d'un traumatisme rénal de grade I, II ou III ?

- A. Traitement non opératoire
- B. Surveillance dynamique de la pression artérielle et de l'hématocrite
- C. Chirurgie d'urgence pour toutes les lésions
- D. Rééquilibrage hydro-électrolytique
- E. Antibiothérapie

***QCM 103. Quelle est la complication fréquente après un traumatisme rénal ?**

- A. Hypertension rénovasculaire secondaire
- B. Formation d'un uro-hématome
- C. Péritonite
- D. Obstruction des voies urinaires
- E. Formation d'un calcul rénal

QCM 104: Quelles sont les causes principales des brûlures ?

- A. Contact avec des liquides ou des vapeurs chauds
- B. Exposition aux radiations
- C. Contact avec des surfaces froides
- D. Contact avec des produits chimiques
- E. Fractures osseuses

QCM 105: Quelles sont les zones de lésion principales dans une brûlure selon Jackson ?

- A. Zone de coagulation centrale
- B. Zone d'hyperthermie
- C. Zone de stase
- D. Zone d'hyperémie
- E. Zone de cicatrisation

***QCM 106: Quelle est la première étape du traitement des brûlures ?**

- A. Réaliser une greffe de peau
- B. Retirer le patient du danger et refroidir la zone brûlée avec de l'eau
- C. Prescrire des antibiotiques immédiatement
- D. Pratiquer une intervention chirurgicale
- E. Administrer des analgésiques puissants

QCM 107: Quelles sont les fractures courantes observées chez les nouveau-nés suite à l'accouchement ?

- A. Fracture de la clavicule
- B. Fracture du fémur
- C. Fracture du tibia
- D. Fracture de l'humérus
- E. Fracture du radius

QCM 108: Quelles sont les fractures spécifiques observées chez l'enfant ?

- A. La fracture de Greenwood
- B. La fracture du péroné
- C. La fracture sous-périostale
- D. La déformation plastique
- E. La fracture par compression

***QCM 109: Quel type de fracture de la classification de Salter-Harris concerne l'écrasement du cartilage de croissance ?**

- A. Type I
- B. Type II
- C. Type III
- D. Type IV
- E. Type V

QCM 110: Quels sont les facteurs de risque associés à la fracture supracondylienne ?

- A. Pratique des sports de contact
- B. Chutes de hauteur
- C. Hypertension
- D. Ostéoporose
- E. Activités nécessitant une position prolongée debout

QCM 111: Quels traitements sont indiqués pour les fractures supracondyliennes de type I et II ?

- A. Immobilisation dans un plâtre pendant 3 à 4 semaines
- B. Réduction orthopédique et brochage percutané avec broches de Kirschner
- C. Fixation externe
- D. Chirurgie avec ostéosynthèse par vis
- E. Traitement conservateur sans immobilisation

***QCM 112: Quelle est la complication potentielle de la fracture supracondylienne ?**

- A. Douleur au genou
- B. Lésion du nerf cubital
- C. Problèmes respiratoires
- D. Saignement nasal
- E. Fracture du pied

QCM 113: Quels sont les facteurs de risque associés à la dysplasie coxo-fémorale congénitale ?

- A. Première naissance
- B. Sexe masculin
- C. Position pelvienne lors de la naissance
- D. Poids à la naissance supérieur à 4000 grammes
- E. Alimentation maternelle

QCM 114: Quel(s) examen(s) sont couramment utilisé(s) pour diagnostiquer la dysplasie coxo fémorale congénitale chez le nourrisson ?

- A. Radiographie du bassin
- B. IRM
- C. Échographie de la hanche
- D. Scanner abdominal
- E. Test de Barlow

***QCM 115: Quel est le traitement initial pour un nourrisson présentant une dysplasie coxo-fémorale congénitale ?**

- A. Harnais de Pavlik pendant 6 semaines
- B. Chirurgie immédiate
- C. Immobilisation dans un plâtre
- D. Physiothérapie
- E. Prothèse de hanche

QCM 116: Quelles sont les théories qui expliquent l'étiopathogénie de la maladie de Legg-Calvé Perthes ?

- A. Théorie vasculaire
- B. Théorie inflammatoire
- C. Théorie génétique
- D. Théorie traumatique
- E. Théorie nutritionnelle

QCM 117: Quels sont les stades de l'évolution de la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?

- A. Stade initial
- B. Stade de croissance
- C. Stade de fragmentation
- D. Stade de réparation
- E. Stade de guérison

***QCM 118: Quel est le traitement recommandé pour un enfant de moins de 8 ans souffrant de la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?**

- A. Orthèses de décharge et thérapie physique
- B. Chirurgie immédiate
- C. Arthroscopie de la hanche
- D. Médicaments antipsychotiques
- E. Immobilisation complète en plâtre

QCM 119: Quels sont les facteurs de risque connus de l'épiphyse fémorale proximale ?

- A. L'obésité
- B. L'hypothyroïdie
- C. L'hyperthyroïdie
- D. L'hypogonadisme
- E. Les synovites transitoires répétées

QCM 120: Quels sont les types de classification utilisés pour l'épiphyse fémorale proximale ?

- A. Aigu
- B. Chronique
- C. Fonctionnel
- D. Stabilité
- E. Hormonal

***QCM 121: Quel est le principal objectif du traitement chirurgical de l'épiphyse fémorale proximale ?**

- A. Réduction et stabilisation du déplacement
- B. Augmentation de la croissance du fémur
- C. Réduction de la douleur uniquement
- D. Amélioration de la mobilité sans stabilisation
- E. Prévention de la nécrose aseptique

QCM 122: Quels facteurs contribuent à l'apparition de la maladie d'Osgood-Schlatter ?

- A. Nécrose avasculaire
- B. Traction du tendon rotulien sur l'apophyse tibiale immature
- C. Hyperlaxité articulaire
- D. Stress répétitif sur la plaque de croissance
- E. Problèmes hormonaux liés à la puberté

QCM 123: Quels traitements sont recommandés pour la maladie d'Osgood-Schlatter ?

- A. Application locale de glace
- B. Physiothérapie et massages avec des pommades anti-inflammatoires
- C. Médicaments anti-inflammatoires oraux à long terme
- D. Repos sportif pendant les périodes douloureuses
- E. Traitement chirurgical immédiat

***QCM 124: Quel est le principal signe clinique de la maladie d'Osgood-Schlatter ?**

- A. Sensibilité et gonflement à la palpation de la tubérosité tibiale
- B. Douleur au genou sans activité sportive préalable
- C. Inflammation de l'articulation du genou
- D. Douleur uniquement après une activité intense
- E. Sensibilité au niveau de l'articulation de la hanche

QCM 125: Quels facteurs peuvent être impliqués dans la survenue de la scoliose ?

- A. Facteurs génétiques
- B. Anomalies de la croissance du rachis
- C. Manque de vitamine D
- D. Anomalies plaquettaires
- E. L'exercice physique excessif

QCM 126: Quelles sont les principales classifications de la scoliose ?

- A. Scoliose idiopathique
- B. Scoliose fonctionnelle
- C. Scoliose congénitale
- D. Scoliose post-traumatique
- E. Scoliose post-infectieuse

***QCM 127: Quel traitement est recommandé pour une scoliose avec une courbure supérieure à 50° ?**

- A. Traitement physiothérapeutique
- B. Port d'un corset orthopédique
- C. Intervention chirurgicale
- D. Traitement médicamenteux
- E. Surveillance sans traitement

QCM 128: Chez quels groupes de personnes les pieds plats ne sont pas considérés comme pathologiques ?

- A. Les enfants de moins de 8 ans
- B. Les enfants de moins de 6 ans
- C. Les adolescents
- D. Les adultes
- E. Les jeunes enfants

QCM 129: Quels sont les types de pieds plats valgus ?

- A. Pied plat rigide valgus
- B. Pied plat valgus flexible
- C. Pied plat valgus avec raccourcissement du tendon d'Achille
- D. Pied plat fonctionnel
- E. Pied plat transitoire

***QCM 130: Quel traitement est recommandé pour un pied plat rigide avec douleur intense ?**

- A. Aucun traitement n'est nécessaire
- B. Utilisation de bottes orthopédiques et physiothérapie
- C. Interventions chirurgicales immédiates
- D. Correction automatique avec l'âge
- E. Port de semelles simples

QCM 131: Quels sont les facteurs de risque potentiels pour le pied bot varus équin congénital ?

- A. Tabagisme maternel
- B. Alcoolisme maternel
- C. Diabète maternel
- D. Infection virale durant la grossesse
- E. Facteurs génétiques

QCM 132: Quelles sont les phases évolutives du pied bot congénital non traité ?

- A. Phase de réductibilité complète
- B. Phase de rigidité absolue
- C. Phase de réductibilité partielle
- D. Phase de rigidité relative
- E. Phase d'aggravation immédiate

***QCM 133: Quelle est la méthode la plus efficace pour traiter le pied bot varus équin congénital ?**

- A. Traitement chirurgical immédiat
- B. Méthode Ponseti
- C. Physiothérapie uniquement
- D. Port de semelles orthopédiques
- E. Utilisation de corsets rigides

QCM 134: Quels sont les facteurs de risque associés au talus valgus congénital ?

- A. Oligoamnios
- B. Poids de naissance élevé
- C. Présentation par le siège
- D. Diabète maternel
- E. Présentation céphalique

QCM 135: Quels traitements sont recommandés pour les formes sévères de talus valgus ?

- A. Physiothérapie et massages
- B. Immobilisation plâtrée en position de correction
- C. Chirurgie immédiate
- D. Orthèses rigides
- E. Aucune intervention nécessaire

***QCM 136: Quel est le pronostic du talus valgus congénital dans la majorité des cas ?**

- A. Le pied ne se corrige jamais
- B. La déformation devient plus sévère avec l'âge
- C. La position vicieuse se corrige spontanément ou par physiothérapie
- D. Une intervention chirurgicale est nécessaire dans tous les cas
- E. Le talus valgus se transforme en pied plat rigide

QCM 137: Quels sont les facteurs de risque du syndrome des loges ?

- A. Fractures
- B. Compression externe par un plâtre serré
- C. Pratique d'exercices physiques modérés
- D. Piqûres d'animaux
- E. Amputations

QCM 138: Quels signes cliniques sont associés au syndrome des loges ?

- A. Douleur intense non soulagée par les analgésiques
- B. Peau rouge et chaude
- C. Pouls faible ou absent
- D. Paralysie de la zone affectée
- E. Augmentation de la pression intra-compartmentale supérieure à 30 mmHg

***QCM 139: Quel traitement est recommandé pour le syndrome des loges ?**

- A. Simple observation sans traitement
- B. Retrait du plâtre ou bandages compressifs
- C. Médicaments antidouleurs uniquement
- D. Chirurgie immédiate sans retrait du plâtre
- E. Immobilisation stricte sans intervention chirurgicale

QCM 140: Quelle est la principale cause de l'ostéomyélite hématogène aiguë chez les enfants de plus de 1 an ?

- A. Streptococcus pneumoniae
- B. Staphylococcus aureus
- C. Mycobacterium tuberculosis
- D. Haemophilus influenzae
- E. Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)

QCM 141: Quels sont les examens diagnostiques utiles dans le diagnostic de l'ostéomyélite hématogène aiguë ?

- A. Radiographie simple
- B. Echographie
- C. Imagerie par résonance magnétique (IRM)
- D. TDM (tomodensitométrie)
- E. Numération formule sanguine (NFS)

***QCM 142: Quel est l'agent infectieux le plus fréquemment incriminé dans l'ostéomyélite aiguë chez les enfants de plus de 1 an ?**

- A. Escherichia coli
- B. Streptococcus pyogenes
- C. Staphylococcus aureus
- D. Salmonella enterica
- E. Pseudomonas aeruginosa

QCM 143: Quelles articulations sont les plus fréquemment touchées par l'arthrite septique chez les enfants ?

- A. Poignet
- B. Coude
- C. Hanche
- D. Genou
- E. Epaule

QCM 144 : Quels sont les agents infectieux les plus fréquemment impliqués dans l'arthrite septique chez les enfants ?

- A. Staphylococcus aureus
- B. Kingella kingae
- C. Streptococcus pneumoniae
- D. Haemophilus influenzae
- E. Mycobacterium tuberculosis

***QCM 145: Quel est le traitement initial recommandé pour l'arthrite septique chez les enfants en attendant les résultats de l'antibiogramme ?**

- A. Antibiotiques par voie orale
- B. Antibiotiques intraveineux à large spectre
- C. Chirurgie seule
- D. Réhydratation intraveineuse
- E. Antifongiques

QCM 146: Quels sont les facteurs qui peuvent provoquer la sténose de la jonction pyélo-urétérale ?

- A. Malformation génétique
- B. Retard dans le processus de recanalisation de l'uretère
- C. Présence d'un vaisseau artériel traversant l'uretère
- D. Infection urinaire
- E. Présence d'une tumeur rénale

QCM 147: Quelles sont les méthodes d'imagerie utilisées pour diagnostiquer et évaluer la sténose de la jonction pyélo-urétérale ?

- A. Echographie
- B. Scintigraphie rénale au Tc-99m DMSA
- C. Radiographie pulmonaire
- D. Uro-CT (Tomodensitométrie) avec contraste
- E. IRM (Imagerie par résonance magnétique)

***QCM 148: Quel est le traitement standard de la sténose de la jonction pyélo-urétérale ?**

- A. Traitement antibiotique
- B. Suivi clinique et échographique uniquement
- C. Pyéloplastie d'Anderson-Hynes
- D. Transplantation rénale
- E. Médicaments anti-inflammatoires

QCM 149: Quels sont les types de mégaurètre mentionnés dans le texte ?

- A. Mégaurètre obstructif
- B. Mégaurètre refluxant
- C. Mégaurètre fonctionnel
- D. Mégaurètre non obstructif, non refluxant
- E. Mégaurètre rénal

QCM 150: Quelles méthodes d'imagerie sont utilisées pour diagnostiquer le mégaurètre et ses complications ?

- A. Echographie
- B. Cystographie
- C. Radiographie pulmonaire
- D. Scintigraphie rénale
- E. IRM abdominale

***QCM 151: Quel est le traitement chirurgical standard pour un mégaurètre obstructif avec une sténose de la jonction urétéro-vésicale ?**

- A. Dilatation endoscopique avec stent urétéral
- B. Pyéloplastie d'Anderson-Hynes
- C. Résection de la portion sténotique et réimplantation de l'uretère dans la vessie
- D. Néphrectomie
- E. Cystoscopie avec drainage

QCM 152: Quelles sont les anomalies qui peuvent résulter d'un système double collecteur ?

- A. Reflux vésico-urétéral
- B. Urétérocèle
- C. Hypoplasie rénale
- D. Sténose urétéro-vésicale
- E. Hydronéphrose

QCM 153: Quelles techniques d'imagerie sont utilisées pour évaluer le système double collecteur ?

- A. Echographie postnatale
- B. Cystographie
- C. Radiographie abdominale
- D. Scintigraphie rénale au DMSA
- E. Uro-IRM

***QCM 154: Quel est le traitement recommandé pour un patient asymptomatique présentant un système double collecteur ?**

- A. Antibiothérapie prolongée
- B. Traitement chirurgical immédiat
- C. Surveillance sans traitement
- D. Réimplémentation de l'uretère
- E. Néphrectomie partielle

QCM 155: Quelles sont les causes fréquentes de l'urétérocèle ?

- A. Résorption incomplète de la membrane urétérale de Chwalla
- B. Sténose urétéro-vésicale
- C. Infection urinaire fréquente
- D. Anomalie de la jonction pyélo-urétérale
- E. Présence d'une duplication urétérale

QCM 156: Quels examens permettent de diagnostiquer l'urétérocèle ?

- A. Echographie postnatale
- B. Echographie fœtale
- C. Cystographie
- D. Radiographie abdominale
- E. Uro-IRM ou uro-TDM

***QCM 157: Quel est le traitement de première intention pour une urétérocèle ?**

- A. Traitement médical par antibiotiques
- B. Chirurgie ouverte pour réimplanter l'uretère
- C. Traitement endourologique par cystoscopie
- D. Dialyse
- E. Néphrectomie partielle

QCM 158: Quelles sont les caractéristiques anatomiques de l'extrophie vésicale ?

- A. Absence de la paroi abdominale antérieure
- B. La vessie est séparée du bas-ventre
- C. Présence d'une déformation du clitoris chez les filles
- D. La vessie est continue avec l'urètre, sans paroi antérieure
- E. Les corps caverneux du pénis sont divergents chez les garçons

QCM 159: Quel diagnostic et traitement sont associés à l'extrophie vésicale ?

- A. Le diagnostic peut être posé par échographie à partir de la 18e à 20e semaine de grossesse
- B. Un traitement médical est généralement suffisant pour fermer la vessie
- C. Le traitement de première intention est chirurgical et doit être réalisé dans les 72 heures suivant la naissance
- D. Chez les garçons, l'épispadias est corrigé à 6-12 mois
- E. Une IRM fœtale est rarement utilisée pour diagnostiquer cette malformation

***QCM 160 : Quel est le pronostic de l'extrophie vésicale ?**

- A. Le pronostic est généralement bon, sans complications après le traitement
- B. Le pronostic dépend de la gravité de la malformation et de la précocité du traitement
- C. Le pronostic ne varie pas selon l'âge de la personne
- D. Le pronostic est uniquement fonction de la capacité rénale
- E. Les patients n'ont généralement pas de problèmes d'incontinence

QCM 161: Quels sont les types de valves urétrales postérieures selon la classification de

Young ?

- A. Type I : Replis urétraux partant sous le verumontanum et fusionnant en avant
- B. Type II : Replis fortement proéminents allant du verumontanum au col vésical
- C. Type III : Diaphragme perforé au-dessus ou au-dessous du verumontanum
- D. Type IV : Replis urétraux au niveau de la vessie uniquement
- E. Type V : Anomalies anatomiques observées au niveau de la vessie

QCM 162: Quels sont les signes cliniques pouvant indiquer des valves urétrales postérieures chez un nourrisson ?

- A. Oligo-anurie, vessie globulaire et abdomen en trèfle
- B. Dysurie, jet urinaire faible, et lombalgie chez les plus âgés
- C. Fièvre et insuffisance rénale chronique
- D. Vessie pleine à paroi épaisse et urétérohydronéphrose bilatérale
- E. Symptômes digestifs sévères comme des vomissements persistants

***QCM 163: Quel est le traitement de choix pour les valves urétrales postérieures après la naissance ?**

- A. Chirurgie de réimplantation urétérale
- B. Ablation endoscopique des valves
- C. Traitement médical avec antibiotiques à vie
- D. Drainage par néphrostomie percutanée
- E. Radiothérapie ciblée sur les valves

QCM 164: Quelles sont les principales anomalies anatomiques observées chez un patient atteint d'hypospadias ?

- A. Méat urétral ectopique sur la face antérieure du pénis
- B. Présence d'un prépuce circulaire complet
- C. Corde fibreuse proximale entraînant une courbure du pénis
- D. Prépuce incomplet avec un excès cutané sur la face dorsale du pénis
- E. Méat urétral situé sur la face dorsale du pénis

QCM 165: Quels sont les objectifs principaux du traitement chirurgical de l'hypospadias ?

- A. Obtenir une courbure du pénis plus prononcée
- B. Amener le méat urétral jusqu'à l'extrémité du pénis
- C. Formation d'un gland symétrique et conique
- D. Créer une sténose urétrale de calibre suffisant
- E. Obtenir une apparence cosmétique optimale, y compris le prépuce

***QCM 166: Qu'est-ce qui distingue l'épispadias de l'hypospadias ?**

- A. L'épispadias présente un méat urétral situé sur la face dorsale du pénis
- B. L'épispadias est une malformation seulement chez les garçons
- C. L'épispadias est une malformation du scrotum
- D. L'épispadias est uniquement diagnostiqué prénatalement
- E. L'épispadias est une malformation fréquente comparée à l'hypospadias

QCM 167: Quelles sont les causes possibles du phimosis acquis ?

- A. Traumatisme local (décapitations intempestives)
- B. Infection urinaire
- C. Balanite aiguë ou chronique
- D. Phimosis congénital
- E. Infection de la peau autour du prépuce

QCM 168: Quelles sont les principales conséquences du phimosis chez les adolescents et les adultes

- A. Infections urinaires
- B. Dysfonctionnement sexuel
- C. Douleur au niveau du pénis, surtout en érection
- D. Difficultés à uriner
- E. Amélioration de la circulation sanguine

***QCM 169: Quel est le traitement recommandé pour un phimosis cicatriciel lorsque les manœuvres de décapitation n'ont pas fonctionné ?**

- A. Traitement antibiotique
- B. Péritonite dorsale de Duhamel
- C. Circoncision
- D. Traitement à base de crèmes
- E. Observation sans traitement